

升阳法论治甲状腺功能减退症*

许趁意, 吕雪莲, 冯志海, 张跃红

河南中医药大学第一附属医院, 河南 郑州 450001

摘要: 甲状腺功能减退症(简称甲减)病机主要为脾肾阳虚、肝郁脾虚。肝郁脾虚即土壅木郁,脾胃虚弱,少阳之气升发不利,是阳气亏损的前奏。随着病情进展,阳气日亏,久则累及脾肾之阳,进而出现脾肾阳虚,其病机演变符合中医“气损及阳”的特点。阳气本于肾、萌于肝胆、滋于脾、壮于心,治疗甲减当升阳、接阳、培阳、固阳,早期肝郁脾虚,治当升阳,方用举元煎合逍遥散加减;中期脾胃虚弱,治当接阳,方用升阳益胃汤加减;后期脾肾阳虚,治当培阳,方用金匱肾气丸合五苓散加减;阳虚凌心,治当固阳,轻者用二仙汤合真武汤,重者用破格救心汤。

关键词: 甲状腺功能减退症;升阳法;阳气;举元煎;逍遥散;升阳益胃汤加减;金匱肾气丸;五苓散加减;二仙汤;真武汤;破格救心汤

DOI:10.16367/j.issn.1003-5028.2025.02.0033

中图分类号:R259.582.2 **文献标志码:**A **文章编号:**1003-5028(2025)02-0194-06

Discussing About the Treatment of Hypothyroidism from the Perspective of "Yang-Raising" Method

XU Chengyi, LYU Xuelian, FENG Zhihai, ZHANG Yuehong

The First Affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou, Henan, China, 450001

Abstract: The pathogenesis of hypothyroidism (referred to as hypothyroidism for short) mainly involves deficiency of spleen-kidney yang and liver depression with spleen deficiency. Liver depression with spleen deficiency means that the earth element is excessive and the wood element is depressed, and the spleen and stomach are weak. The ascending of the yang *qi* of the lesser yang meridian is not smooth, which is a prelude to the deficiency of yang *qi*. As the disease progresses, the yang *qi* gradually declines. If it persists for a long time, it will affect the yang *qi* of the spleen and kidney, and then lead to deficiency of spleen and kidney yang. The evolution of its pathogenesis conforms to the characteristics of the TCM pathogenesis of "qi deficiency leading to yang deficiency". Yang *qi* originates from the kidney, sprouts in the liver and gallbladder, nourishes in the spleen and grows in the heart. The treatment should focus on uplifting yang, connecting yang, nourishing yang and consolidating yang. For early-stage liver depression and spleen deficiency (with the inability of the lesser yang energy to ascend), the treatment should focus on raising the yang energy, so Modified Decoction for Lifting Original *Qi* combined with Free Wanderer Powder can be used. For the condition of spleen and stomach weakness in the middle energizer, the treatment should focus on connecting yang, so Modified Yang-Raising and Stomach-Replenishing Decoction can be used. In the later stage, when there is deficiency of yang in the spleen and kidney, the treatment should focus on nourishing yang, so Modified Golden Cabinet's Kidney *Qi* Pill combined with Five Substances Powder with Poria can be used. When yang deficiency invades the heart, the treatment should focus on consolidating yang. For mild cases, Two-elixir Decoction combined with True Warrior Decoction can be used. For severe

* **基金项目:** 河南省中医药管理局项目(2019HL-089-03); 2023 年度河南省卫生健康委员会国家中医药传承创新中心科研专项项目(2023ZXZX1135)

• 194 •

cases, Poge Life-Saving Decoction is recommended.

Keywords: hypothyroidism; "yang-raising" method; yang qi; Decoction for Lifting Original Qi; Free Wanderer Powder; Modified Yang-Raising and Stomach-Replenishing Decoction; Golden Cabinet's Kidney Qi Pill; Modified Five Substances Powder with Poria; Two-elixir Decoction; True Warrior Decoction; Poge Life-Saving Decoction

甲状腺功能减退症是甲状腺激素缺乏引起的病理综合征^[1]。甲状腺遗传缺陷、甲状腺手术切除、¹³¹I 甲状腺消融术或甲状腺自身免疫破坏等引起的甲状腺激素缺乏是甲状腺功能减退症的常见病因^[2]。成人最常见的临床症状表现为疲劳、嗜睡、不耐冷、体质量增加、排便异常、声音变化和皮肤干燥等,患者或因年龄和性别不同表现不同的症状^[2]。目前,我国甲状腺功能减退症患病率约为 17.8%,其中临床甲状腺功能减退症约为 1.1%,亚临床甲状腺功能减退症约为 16.7%^[3]。左甲状腺素(levothyroxine)是治疗本病的有效药物,对大多数甲状腺功能减退症患者有效。然而,少数患者虽甲状腺激素水平正常,但甲状腺功能减退症的症状一直存在^[2],影响了患者生存质量。中医具有整体观、个性化的独特辨证优势,在改善患者症状,提高生活质量方面积累了丰富的经验,可有效改善部分甲状腺功能减退症患者的症状。

中医将甲状腺功能减退症归属于“虚劳”“劳瘵”及“瘵病”范畴^[4],笔者结合其临床表现及治疗法则,认为其病机演变符合中医“气损及阳”的特点,阐述如下。

1 阳气的发展与壮大

《素问·生气通天论》曰:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰。”^[5]阳气之于人体,犹太阳之于天地。天地无太阳,则万物不荣;人体无阳气,则形容枯槁。张景岳《类经附翼·求正录》言:“天之大宝,只此一丸红日;人之大宝,只此一息真阳。”^[6]人体机能的维持及代谢功能的发挥,与阳气的盈亏关系密切。甲状腺功能减退,与阳气的亏损或阻塞关系密切。

1.1 本于肾 肾为先天之本,水火之宅,寓藏元阴元阳。肾中所藏之精,以化肾气,肾气分肾阴与肾阳,而人体阳气的化生,本于肾阳。所谓肾阳,即是藏于肾中,具有积极、推动、温煦及宣散作用之气的

总称;与藏于肾中,具有消极、抑制、凉润及凝聚作用的肾阴之气相呼应。肾阳为人体阳气的根本,肾阳充足,则人体一派生机,气血津液运行通畅,新陈代谢正常,是人体健康的基石;肾阳不足,则人体一派萎靡,气血津液运行滞涩,新陈代谢紊乱,是人体疾病发生之本源。

“五脏之阳,非此不能发”。肾阳为基,五脏之阳乃至人体的阳气,均来源于肾阳的上下输布。肾阳虚弱,不仅可表现出肾脏本脏的虚寒证候,还可引起心阳、脾阳不足,引发一系列疾病。肾阳亏虚,可出现虚寒疝气、外囊肿大、遗精、小便不禁等肾脏自身症状,《医学入门·脏腑六脉诊法》言:“肾涩则虚寒……小肠疝气,胞囊肿大……精于梦中遗漏。”^[7]《诸病源候论·小便不禁候》言:“小便不禁者,肾气虚”^[8]。肾阳亏虚,他脏必受其累,肾阳虚惫,火不暖土,可见五更肾泄,治需补肾阳;君火以明,相火以位,君在上如离照当空,相在下为神明之基,肾阳损及心阳,可见胸痹心痛,治以温肾助心,则上下交济,各安其位。《素问·至真要大论》曰:“热之而寒者取之阳。”^[5]王冰注曰:“益火之源,以消阴翳。”火之源在肾,肾阳升发输布,则阴霾自散,故肾阳为一身阳气的根本,阳气根于肾。

1.2 萌于肝胆 《素问·六节脏象论》曰:“凡十一脏取决于胆也。”胆为阳中之少阳,为稚阳,人体阳气的升发,赖胆气以条达周身,胆气升发,则余脏升发,胆气把阳升之气,引导至其他脏腑,犹如火种,人身之阳气的火焰赖少阳胆气以点燃。诚如李东垣在《脾胃论·脾胃虚实传变论》中言:“胆者,少阳春生之气,春气升则万化安……胆气春升,则余脏从之。”^[9]少阳阳气犹如初生之幼苗,亦如阳气之火种。仲景在治疗少阳陷于太阴的病证时,方用柴胡桂枝干姜汤,方中柴胡、桂枝、干姜能促使少阳之阳气升发,使陷里之阳得以升发。李东垣多以助胆气升发来培补人体脾胃阳气的虚衰,如其在《脾胃论·脾胃胜衰论》中所述:“脾胃不足之源,乃阳气

不足,阴气有余”“升发阳气以滋肝胆之用,是令阳气生。”^[9]因此,胆为升阳之苗,胆气升则阳气升。

1.3 滋于脾 阳气的发展与壮大,不仅需要阴中所寓一息真元的升发,更离不开后天水谷精微的滋养培育。脾为气血之化源,属土,阳气萌于胆,破土而出,赖于脾胃之土的滋养。《灵枢·五味》言:“故谷不入,半日则气衰,一日则气少矣。”人以五谷养五脏,谷气蒸腾宣发,熏肤充身,如溉雾露,此即人体之阳气。阳气可“精则养神,柔者养筋”,人体的精神与形体,都离不开阳气的滋养,神得阳养则精神慧爽,筋得阳养则筋肌柔韧。故人体精神颓废、形体的衰惫,是阳气虚弱的表现。

1.4 壮于心 心为君主之官,五脏六腑之大主,为阳脏,通于夏气。心阳为君火,《医学真传》云:“天有日,人亦有日,君火之阳,日也。”心之阳气,犹如人身之太阳,离照当空,阴霾自散。“阳气者,精则养神”,心阳不仅可推动心脉的血液运行,维持形体的生理机能,还可濡养心神,使人体神清气爽,精神充沛。若久病阳虚,轻者脾肾阳气虚弱,重者阳虚堤坝不固,水饮泛滥,凌心犯肺,使心阳不展,心神蒙尘。抑或痰浊、瘀血等实邪阻滞心脉,心脉不通,心阳亦可受损,引起机体形神的异常。故而,心为火脏,可烛照万物,主明则下安,心阳为身体阳气的精粹,若受凌犯,则祸乱蜂起。

2 阳气与甲状腺功能减退症

2.1 甲状腺内寓阳气 甲状腺位居颈部“清净无为之地”,与五脏六腑络属关系不甚密切,既不似脏,可“满而不实”,藏泄有度;又不类腑,可“实而不满”,传化有序。从取类比象的角度来看,因其外形似从土壤中萌发的“谷芽”,故其性升发向上,五行属肝胆之木,得春气升发之令,具有宣发、升散的特点。其升发太过,亢则为害,可见突眼、心烦多怒、汗出异常、四肢抖动等“木盛风动”之象,属“甲状腺功能亢进症”范畴;若升发不及,木郁于土中,土壅木郁,可见神情淡漠、畏冷乏力、反应迟钝及下肢水肿等“阳虚阴盛”的症状。另甲状腺因其内藏“甲状腺素”,具有促进生长发育、调节新陈代谢、兴奋神经、心脏及促进食欲等作用^[10],这与中医“阳气”的作用

相似^[11]。因此,甲状腺激素水平与中医的阳气有一定关系。

2.2 阳虚是甲状腺功能减退症病机演变的核心

甲状腺功能减退症是一种以甲状腺激素合成分泌减少或作用减弱为特征的低代谢疾病^[12],主要表现为乏力、畏寒、四肢肿胀感、体质量增加、记忆力减退及女性月经紊乱等。现代学者研究认为,中医病机主要为脾肾阳虚、肝郁脾虚^[13]。而阳气滋于脾、壮于心、本于肾,所谓肝郁脾虚,即是土壅木郁,脾胃虚弱,少阳之气升发不利,其是阳气亏损的前奏。随着病情的进展,阳气日亏,久则累及脾肾之阳,进而出现脾肾阳虚的证型。因此,本病早期表现为肝郁脾虚证,随着病程进展,气损及阳,则见脾肾阳虚,其病机是一种动态演变的过程,而其病机核心在于阳虚。

2.3 阳气的运行规律与甲状腺功能减退症

2.3.1 情绪抑郁、缺乏主动性 春气升则万化安,胆之阳气不发,机体一派沉寂,可发为抑郁,表现为情绪低落、意志消沉。肝胆互为表里,胆气不升,肝气郁滞,气机不畅,一有拂郁,则诸病由生,此因病而致郁者。《景岳全书·郁证》言:“凡五气之郁则诸病皆有,此因病而郁也。”木气不升,郁于土中,土壅木郁,情志不遂,气机不达,耗伤心脾之气,神失所养,故而情绪低落、缺乏主动性。甲状腺功能减退患者,由于胆气不升,气机不畅,促使甲状腺激素分泌不足,导致低代谢率及低交感神经兴奋而表现为上述症状。

2.3.2 四肢乏力、胃纳减退 脾胃为水谷之海,气血生化之源,五脏之气,赖水谷之气的滋养。脾主运化,食饮得运化以成水谷之精,脾病则水谷之气不达,见四肢痿废不用;胃主受纳,脾病及胃,纳运失司,则见食欲减退。脾胃虚弱,甲状腺无以充养,即为甲状腺激素合成减少(阳无所滋),可见四肢乏力、胃纳减退。

2.3.3 畏寒、水肿及闭经 肾内寓肾阴肾阳,久病及肾,肾阳亏虚,机体一派虚寒之象。肾者主水,为胃之关,关门不利,肾不化气,犹釜底无薪,水邪泛滥,则见肢体水肿。阳主温煦,肾阳为一身阳气之根本,肾阳不足,机体难以温养,则见畏寒怕冷;肾主生殖发育,肾精不足,天癸无养,经血不以时下,故见闭

经。

2.3.4 谵妄、抽搐及昏迷 诸风为病,多责之于肝。或因气血亏虚,或因痰火内动,或因邪热亢盛,或因久病水不涵木,以致肝风内动,累及心神,则见谵妄、抽搐和昏迷。甲状腺功能减退症重症患者,由于甲状腺激素的过度缺乏,机体新陈代谢及中枢神经兴奋性降低,脑供血及脑神经活动受累,故见上述症状,此为阳虚较重,不能濡养心神,心神动荡,即中医之“心阳虚弱、邪气凌心”之证。

3 升阳法分期论治甲状腺功能减退症

3.1 升阳法 《素问·阴阳应象大论》言:“清阳出上窍,浊阴出下窍”,又云:“清气在下,则生飧泄”,说明人体饮食所化生的水谷清气(即为阳气)具有向上、向外升发的特点。脾主升清,胃主降浊,李东垣《脾胃论·脾胃胜衰论》认为,脾胃不足之源,是阳气不足,阴气有余,而谈及升阳之法,其言:“以诸风药,升发阳气,以滋肝胆之用,是令阳气生……未用辛甘温药接其升药,使火发散于阳分。”这与张锡纯之元气“基于肾,萌芽于肝,培养于脾”的观点契合,而心又为火脏,故阳气与肝胆、肾、脾、心等脏腑相关。阳气本于肾、萌于肝胆、滋于脾、壮于心,故笔者所提升阳之法,包含升阳(升发少阳)、接阳(甘温健脾)、培阳(培补元阳)及固阳(温阳化水)。

3.2 分期论治甲状腺功能减退症

3.2.1 早期肝郁脾虚,治当升阳 甲状腺功能减退症初期,症状多不典型,病机多为情志不畅,或所愿不遂,木壅土郁,胆气不升。症见:颈部瘰疬较小或无,面色少华,情绪低落,胸闷太息,肢体倦怠,女性患者则会伴有月经量少,眼睑浮肿,或伴体质量增加等,舌淡苔白,脉弦细。治疗当升发少阳之气,疏肝健脾,助阳以升。方选举元煎合逍遥散加减,具体方药可用党参、黄芪、升麻、炙甘草、白术、北柴胡、当归、白芍、茯苓、薄荷等。阳虚畏寒明显者加桂枝、干姜等;血虚面色少华、月经量少者加熟地黄、山茱萸、当归、川芎等;眼睑浮肿,湿邪不攘者加砂仁、厚朴、半夏、陈皮、车前子等。

3.2.2 中期脾胃虚弱,治当接阳 病至中期,虚惫之象愈显,症见:四肢倦怠乏力,手足不温,食少纳

差,腹胀,面色萎黄,颜面浮肿,体质量增加,爪甲不荣,皮肤干燥,失眠健忘,或见大便秘结,舌淡胖有齿痕,脉弱或缓。治疗当益气健脾、助阳益胃,方选升阳益胃汤加减。具体药物可用生晒参、黄芪、白术、升麻、黄连、半夏、陈皮、茯苓、防风、泽泻、羌活、独活、北柴胡、白芍等。若面色萎黄,爪甲不荣,气血不足,加用熟地黄、当归、川芎等;若手足不温,畏寒明显,加用菟丝子、巴戟天、淫羊藿等;若大便秘结,加大生白术用量,加枳实、荷叶等;若失眠健忘,加酸枣仁、远志、石菖蒲等。

3.2.3 后期脾肾阳虚,治当培阳 阳虚日久,伤及肾阳,损及根本。症见:面色㿔白,畏寒肢冷,四肢水肿,按之凹陷,心悸胸闷,气短乏力,动则加重,小便不利,舌淡嫩苔水滑,脉沉迟无力,治当温脾肾之阳,金匮肾气丸合五苓散加减,药用附子、桂枝、熟地黄、山药、酒萸肉、茯苓、泽泻、白术、猪苓等。若阳虚畏寒较重,加菟丝子、鹿角胶、巴戟天、淫羊藿等;若四肢水肿较重,加川牛膝、车前子、牵牛子等;若气短乏力、动则加重,重用淡附片,加用生晒参、干姜、山萸肉等。

3.2.4 阳虚凌心,治当固阳 久病阳虚,心阳不足,阴邪上乘,水泛凌心。症见:心悸惕如人将捕之,心慌气短,动则加重,畏寒,表情呆滞,反应能力下降,小便量少或无尿,脉沉无力。治当温阳化水,轻者用二仙汤合真武汤,重者用破格救心汤。药用茯苓、白芍、附子、白术、生姜、仙茅、淫羊藿、巴戟天、熟地黄等。心悸较重,加茯苓、猪苓、泽泻、桂枝、炙甘草;智力下降,加远志、石菖蒲、茯神、生晒参,或加用导痰汤;表情淡漠、心境抑郁、心率慢,加麻黄、细辛、生晒参等。

4 验案举隅

赵某,男,21岁,学生,以“颈前肿大3个月,面部浮肿、乏力半个月”为主诉于2023年5月6日至河南中医药大学第一附属医院内分泌科就诊。2023年5月5日,郑州大学第一附属医院行甲状腺功能检查示:游离甲状腺素3(free thyroxine, FT3): $2.92\text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$,游离甲状腺素4(free thyroxine, FT4): $0.01\text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$,促甲状腺激素(thyroid stimu-

lating hormone, TSH): $312.55 \text{ uIU} \cdot \text{mL}^{-1}$, 甲状腺过氧化物酶抗体(thyroid peroxidase antibody, TPO - Ab): $> 600 \text{ IU} \cdot \text{mL}^{-1}$, 甲状腺球蛋白抗体(thyroglobulin antibodies, TGA b): $> 4\ 000 \text{ IU} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。心肌酶: 肌酸激酶: $2\ 460 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, 乳酸脱氢酶: $323 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, α -羟丁酸脱氢酶: $261 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, 肌酸激酶同工酶: $34.5 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$ 。刻下症见: 颈部甲状腺 I 度肿大, 面部浮肿, 时有心前区刺痛, 胸闷, 气短乏力, 嗜睡, 饮食正常, 小便未见异常, 睡眠可, 大便每日 3 次, 质稀便溏, 舌质暗红, 苔白, 脉沉。西医诊断: 甲状腺功能减退症, 予优甲乐口服治疗。中医诊断: 瘰病, 心肾阳虚证, 予二仙汤合保元汤加减温肾益心, 药物组成: 仙茅 10 g, 淫羊藿 10 g, 生姜 18 g, 炙甘草 10 g, 肉桂(后下) 8 g, 黄芪 30 g, 党参 10 g, 车前草 30 g, 炒苦杏仁 15 g, 茯苓 30 g, 薏苡仁 30 g, 石菖蒲 30 g。共 9 剂, 水煎服, 每日 1 剂, 一天 3 次。

二诊: 服药后, 面部浮肿及胸闷、气短乏力症状较前明显减轻, 2023 年 5 月 13 日复查甲状腺功能: FT3: $3.25 \text{ pmol} \cdot \text{L}^{-1}$, FT4: $2.81 \text{ pmol} \cdot \text{L}^{-1}$, TSH: $258.53 \text{ uIU} \cdot \text{mL}^{-1}$; 心肌酶: 肌酸激酶: $1\ 109.3 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, 乳酸脱氢酶: $249.8 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, α -羟丁酸脱氢酶: $213.8 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, 肌酸激酶同工酶: $4.6 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$ 。患者症状改善, 病情较前好转, 继续守方治疗。

三诊: 面部浮肿症状明显好转, 活动后胸闷、气短乏力症状较前缓解, 2023 年 6 月 1 日复查甲状腺功能: FT3: $4.54 \text{ pmol} \cdot \text{L}^{-1}$, FT4: $8.54 \text{ pmol} \cdot \text{L}^{-1}$, TSH: $95.22 \text{ uIU} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。守上方治疗, 后电话随访, 活动后已无胸闷、气短乏力症状。

按语: 人之阳气, 本于肾, 赖少阳升发之气, 运输于机体, 得后天脾胃滋养, 以充养心阳, 使神有所主, 形有所依。此案患者, 因面部浮肿、乏力就诊, 诉在校期间, 胸闷乏力症状较重, 缘由甲状腺激素(少阳升发之气)的缺乏引起心脏疾病(心阳亏耗), 心火蒙蔽, 水饮泛溢, 辨证属中医心肾阳虚证, 予以“优甲乐”补充甲状腺激素, 即是助少阳之气的升发, 再以二仙汤合保元汤温肾益心, 俾阳气复而心阳得充, 水饮化而君火以明, 阳盛则阴翳自退。

5 小结

甲状腺功能减退症患者多表现出阳虚证候, 而

现代研究亦证实^[14-20], 此病多发生于气虚及阳虚体质者, 因此, 可从阳气角度分析甲状腺功能减退症病因病机。现代中医学者^[21-24]亦认为本病与气虚、阳虚相关, 但鲜有医家对阳气与甲状腺功能减退症的病机演变进行系统论述。

张锡纯《医学衷中参西录》言:“元气根基于肾, 萌芽于肝, 培养于脾……”提出阳气“本于肾、萌于胆、滋于脾、壮于心”的观点。对于阳虚证的治疗, 笔者参阅李东垣《脾胃论》所言:“升发阳气, 以滋肝胆之用, 是令阳气生。”提出升阳之法, 包含升阳(升发少阳)、接阳(甘温健脾)、培阳(培补元阳)及固阳(温阳化水)。甲状腺功能减退症初期, 土壅木郁, 脾虚少阳不升, 当治以升阳; 中期, 脾胃虚弱, 阳气不得接续, 当治以接阳; 后期, 脾肾阳虚, 元阳亏虚, 当治以培阳; 病程日久, 伤及心气、累及心阳, 出现阳虚水泛证候, 当治以固阳。

参考文献:

- [1] CHAKER L, BIANCO A C, JONKLAAS J, et al. Hypothyroidism[J]. Lancet, 2017, 390(10101): 1550-1562.
- [2] BIANCO A C. Emerging therapies in hypothyroidism[J]. Annu Rev Med, 2024, 75(5): 307-319.
- [3] 李连喜. 2017 年成人甲状腺功能减退症诊治指南解读[J]. 世界临床药物, 2018, 39(12): 793-799.
- [4] 中国医师协会中西医结合医师分会内分泌与代谢病专业委员会, 庞国明, 倪青. 成人原发性甲状腺功能减退症病证结合诊疗指南[J]. 世界中医药, 2023, 18(16): 2265-2272.
- [5] 鲁瑛. 中医四部经典[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2008.
- [6] 张介宾. 类经图翼: 十一卷[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1958.
- [7] 李梴. 医学入门[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2013.
- [8] 巢元方. 诸病源候论[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1997.
- [9] 李杲. 脾胃论[M]. 影印本. 北京: 人民卫生出版社, 1957.
- [10] 王庭槐. 生理学[M]. 9 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 376-379.
- [11] 孙广仁. 中医基础理论[M]. 北京: 中国中医药出版

- 社,2010:75.
- [12] 卡斯帕. 哈里森内科学·内分泌与代谢疾病分册[M]. 纪立农,译. 19 版. 北京:北京大学医学出版社,2016:71-77.
- [13] 蒋里,赵进喜. 甲状腺功能减退症中医临床研究述评[J]. 北京中医药,2021,40(11):1178-1182.
- [14] SARAVANAN P, CHAU W F, ROBERTS N, et al. Psychological well-being in patients on "adequate" doses of l-thyroxine; results of a large, controlled community-based questionnaire study[J]. Clinical endocrinology, 2007,57(5):577-585.
- [15] PETERSON S J, CAPPOLA A R, REGINA CASTRO M, et al. An online survey of hypothyroid patients demonstrates prominent dissatisfaction[J]. Thyroid, 2018, 28(6):707-721.
- [16] MCANINCH E A, RAJAN K B, MILLER C H, et al. Systemic thyroid hormone status during levothyroxine therapy in hypothyroidism: a systematic review and meta-analysis[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2018, 103(12):4533-4542.
- [17] 李婵. 陈如泉教授治疗亚急性甲状腺炎学术思想及临床经验的总结[D]. 武汉:湖北中医药大学,2012.
- [18] 李昕潼,邓秀敏,周一,等. 从罢极之本论治桥本甲状腺炎[J]. 世界中医药,2021,16(12):1879-1883.
- [19] 周建龙,岳仁宋,刘慧玲,等. 从少阳温病论治亚急性甲状腺炎[J]. 中华中医药杂志,2017,32(9):3940-3942.
- [20] 夏仲元,王琦,郭琪,等. 甲亢和甲减中医体质类型调查分析[J]. 北京中医药大学学报,2010,33(4):280-282.
- [21] 王耀立,魏军平. 魏军平治疗甲状腺功能减退症经验[J]. 中国中医基础医学杂志,2016,22(6):869-871.
- [22] 徐蓉娟,葛芳芳,李红. 中医辨治甲状腺功能减退症[J]. 上海中医药大学学报,2007,21(6):42-43.
- [23] 马占英,景录先. 景录先治疗甲状腺功能减退症经验浅析[J]. 中华中医药杂志,2019,34(9):4123-4125.
- [24] 李秋莲,刘海鹏,王颜琦,等. 基于数据挖掘的近10年中医辨治甲状腺功能减退症用药规律探讨[J]. 云南中医学院学报,2020,43(6):79-84.
- 收稿日期:2024-10-19
- 作者简介:许趁意(1991-),男,河南上蔡人,博士研究生。
- 通信作者:张跃红,E-mail:15637100169@wo.cn
- (编辑:刘华)